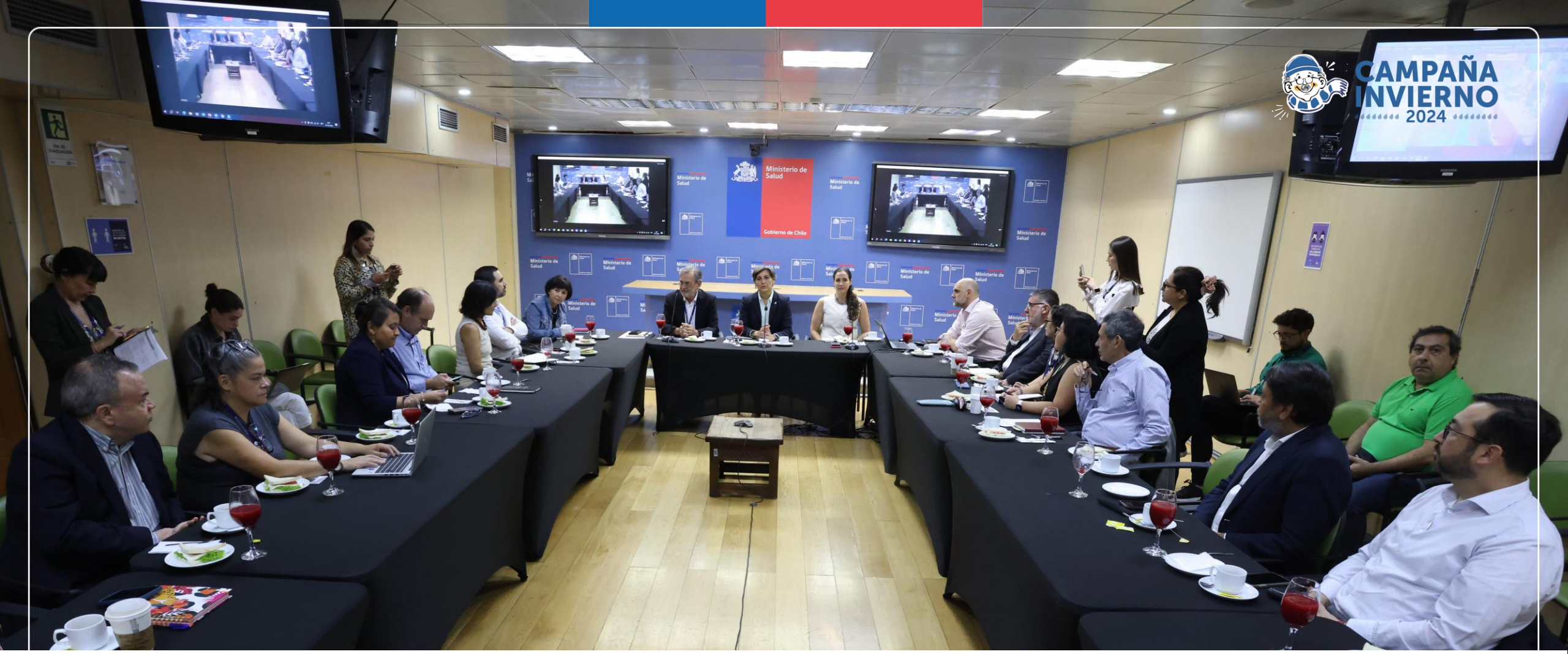
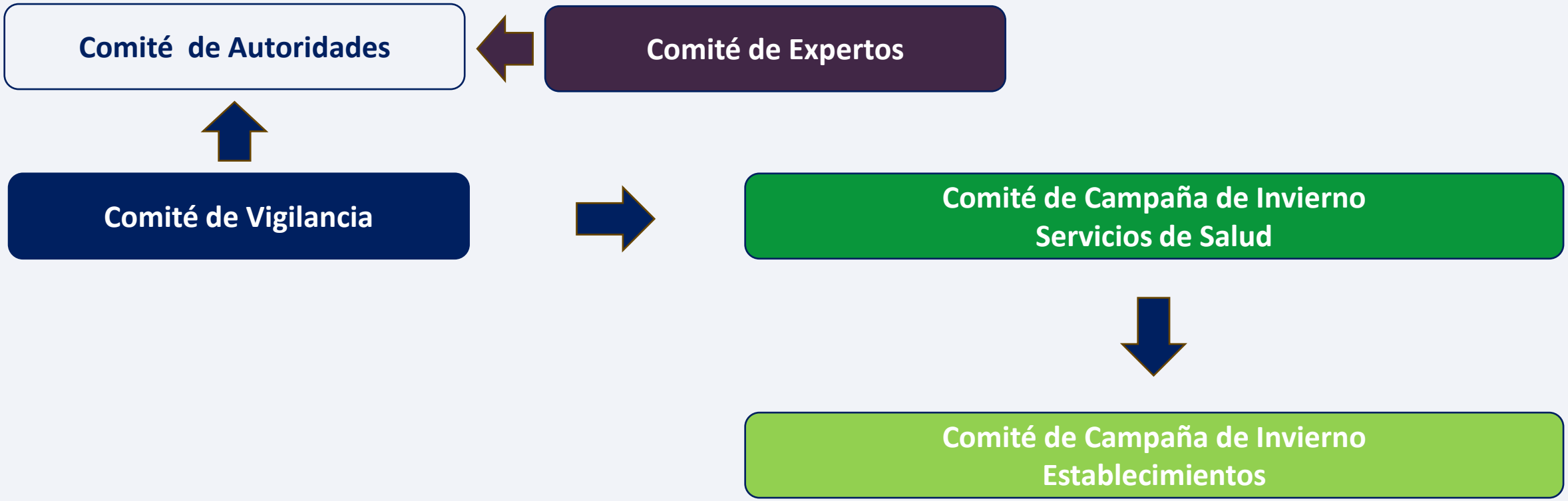
PLAN CAMPAÑA DE INVIERNO 2025

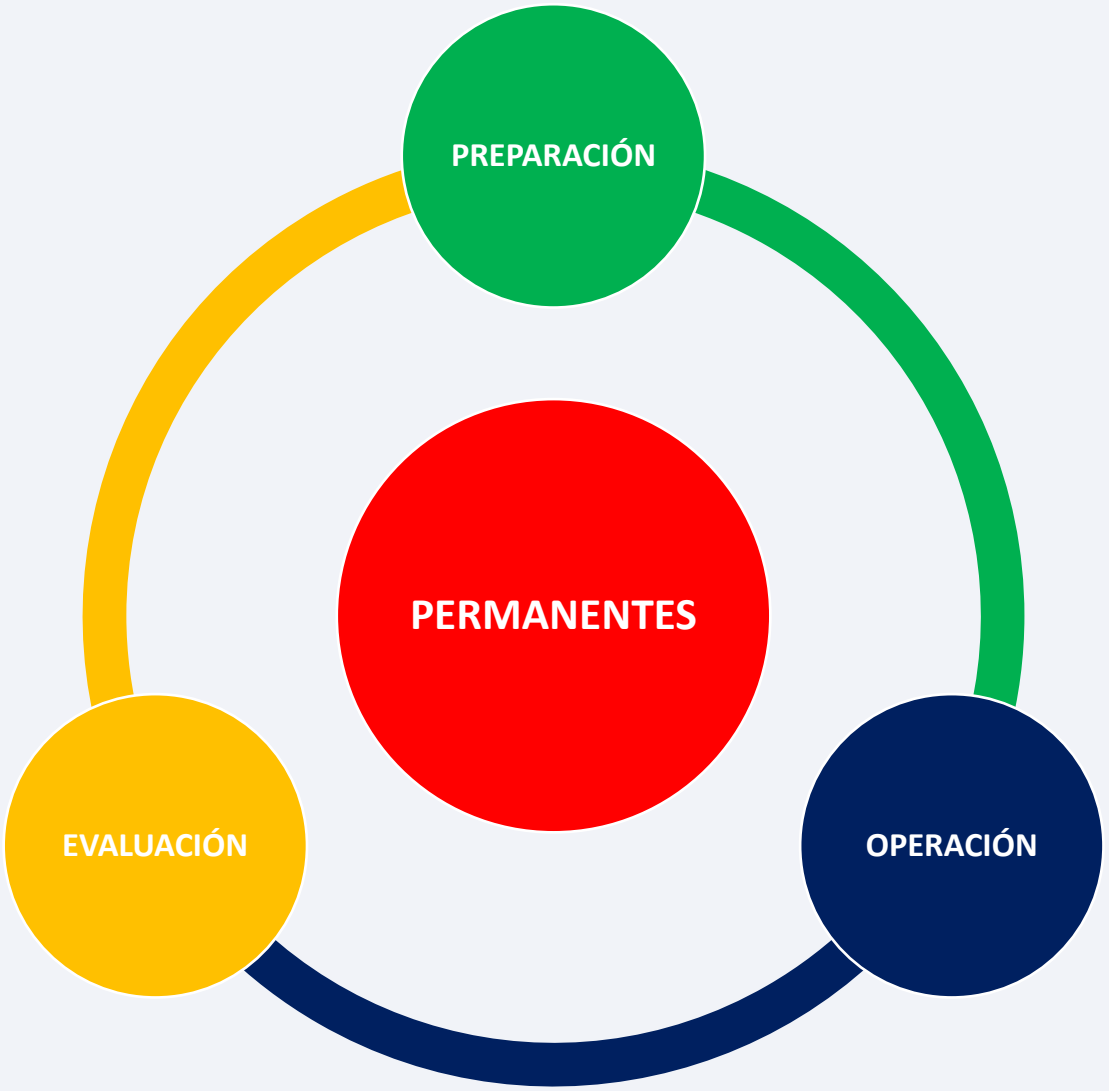


PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN MINSAL

ORGANIZACIÓN



EL PLAN



Objetivo

Disminuir la morbimortalidad de la población producto de las enfermedades respiratorias.

Asegurar una respuesta sanitaria temprana, integrada, oportuna, eficiente y eficaz ante el aumento de enfermedades respiratorias que tiene lugar cada otoño e invierno.

ESTRUCTURA PLAN CAMPAÑA DE INVIERNO 2025

CAMPAÑA INVIERNO 2025

- LE 1. VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA CENTINELA IRAG/ETI
- LE 2. PREVENCIÓN: COMUNICACIÓN DE RIESGO, VACUNACIÓN E INMUNIZACIONES
- LE 3. FORTALECIMIENTO DE LA RESPUESTA DE LA APS
- LE 4. FORTALECIMIENTO DE LA RESPUESTA DEL NIVEL DE ATENCIÓN HOSPITALARIA
- LE 5. CAPACITACIÓN Y GENERACIÓN DE COMPETENCIAS
- LE 6. SALUD DIGITAL
- LE 7. SALUD MENTAL
- LE 8. GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES
- LE 9. CALIDAD Y SEGURIDAD DE LA ATENCIÓN

LE 1. VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA

ACCIONES INICIALES PREVENTIVAS Y DE ALERTA

- **Decreto de Alerta Sanitaria** preventiva (03/03/2025) hasta el 30/09/2025 para enfrentar la amenaza a la salud pública producida por el aumento de virus respiratorios estacionales, que permitió disponer el **Uso de mascarillas obligatorio en la red de urgencia** de todos los niveles de atención, entre el periodo de **abril a agosto** del presente año (RE 344/2025).

- Declaración de **alerta epidemiológica** (Ord 1080 del 11/04/2025) debido al aumento de casos en la vigilancia de enfermedad invasora por ***S. Pyógenes* y *Mycoplasma pneumoniae.***

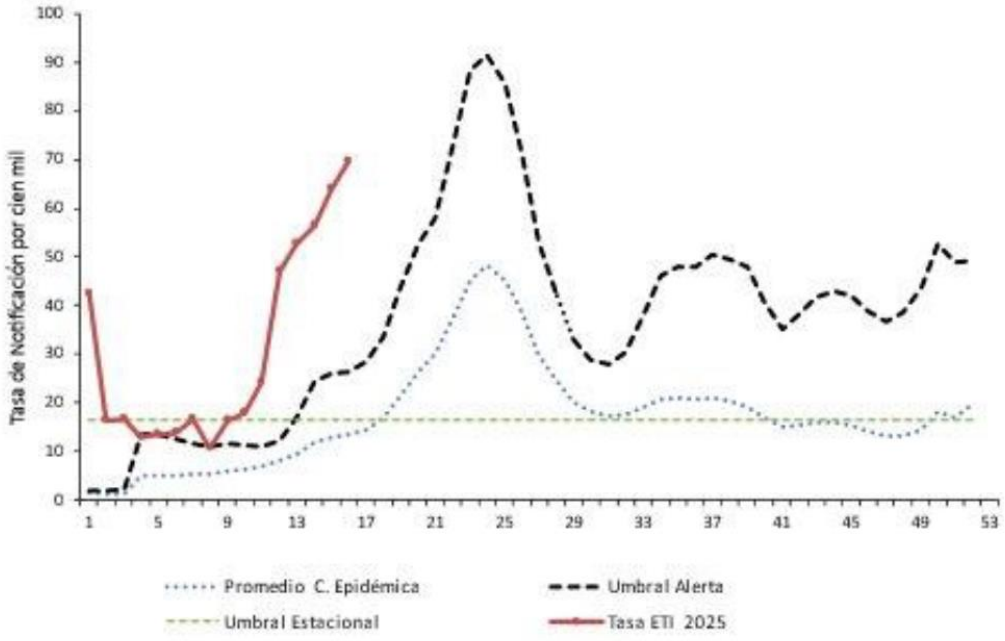
VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA

Enfermedades Tipo Influenza (ETI)
Infecciones Respiratorias Agudas Graves (IRAG)
Vigilancia de Laboratorio ISP

Identificar cambios en la tendencia de circulación viral, evaluar patrones de transmisión, gravedad clínica y su impacto en el sistema de salud.

VIGILANCIA ENFERMEDAD TIPO INFLUENZA

Figura 3. Notificación de Enfermedad Tipo Influenza en establecimientos de salud de Atención Primaria según Semana Epidemiológica. Chile, SE 1-16 del 2025 (Comparado con 2017 – 2024).



- **Tasa de notificación:** 69,7 casos cada 100.000 habitantes ↑
- **Regiones con mayor tasa:** Magallanes, O'Higgins y Los Lagos.

Tabla 1. Distribución de casos ETI según región de notificación. Chile, SE 16 de 2025.

Región	Nº Casos	Población	Tasas x 100.000 hab*
Arica-Parinacota	8	38593	20,7
Tarapacá	25	81000	30,9
Antofagasta	46	142264	32,3
Atacama	18	25882	69,5
Coquimbo	23	69823	32,9
Valparaíso	355	309.351	114,8
Metropolitana	197	323023	61,0
O'Higgins	75	51469	145,7
Maule	28	83598	33,5
Ñuble	7	30627	22,9
Biobío	80	134993	59,3
Araucanía	43	85864	50,1
Los Ríos	15	56138	26,7
Los Lagos	183	128090	142,9
Aysén	11	79876	13,8
Magallanes	48	27025	177,6
País	1162	1667616	69,7

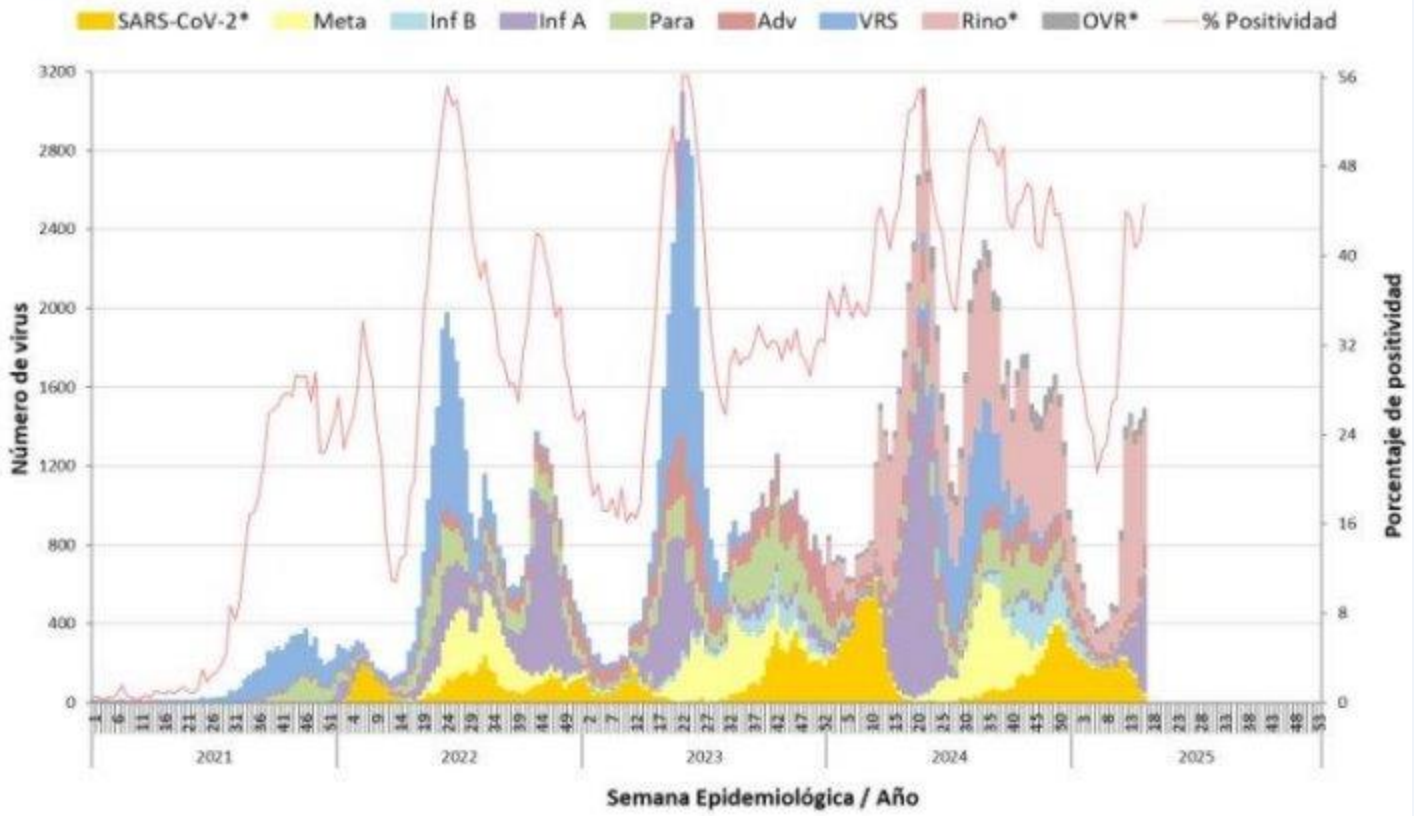
Adherencia al reporte: 100%

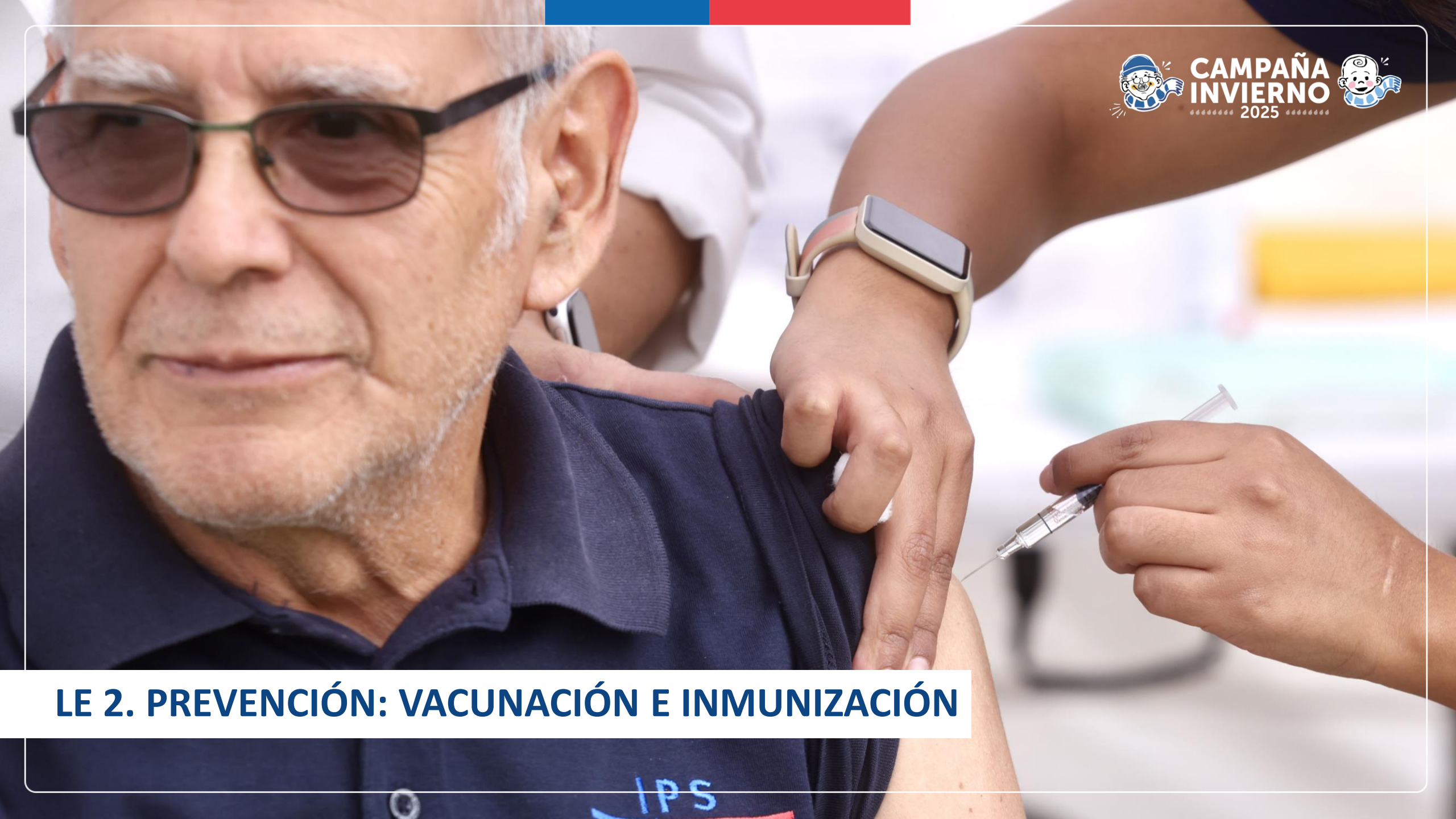
Fuente: Vigilancia Centinela ETI.
Elaboración propia: Depto. Epidemiología. Fecha de extracción 22-04-2025.

VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA

- **Positividad global:44,6%**
- **Virus más detectado:**
  - Rinovirus 41,9%
  - Influenza A: 40,4%
- **Grupo etario más afectado:1 a 4 años**
- **Ciudades más afectadas:**
  - Santiago
  - Punta Arenas
  - Concepción

Figura 1. Positividad global y número de casos detectados de virus respiratorios por Semana Epidemiológica. Chile, SE 1-16 de 2025 (Comparado con 2021 – 2025).





CAMPAÑA INVIERNO 2025

LE 2. PREVENCIÓN: VACUNACIÓN E INMUNIZACIÓN

VACUNACIÓN E INMUNIZACIÓN 2025

Influenza / COVID-19 / VRS / Coqueluche / Neumococo

Innovaciones campaña 2025

- Adelantamiento de campaña de inmunización al 1 de Marzo
- Implementación de puntos de vacunación en establecimientos de alta y mediana complejidad
- Adquisición de **anticuerpo monoclonal** para proteger de la muerte o enfermedad grave por VRS a todos los niños nacidos desde octubre del 2024.
  - cobertura 2024: 90,4% (lactantes) y 97,3% (recién nacidos)

VACUNACIÓN E INMUNIZACIÓN 2025

CAMPAÑA INVIERNO 2025

Cobertura nacional: 55,07% al 23 de abril

Figura 18. Dosis administradas acumuladas Campaña de Vacunación Influenza de los grupos objetivo. Chile, 22 de abril de 2025.

OTRAS ACCIONES RELEVANTES

Colaboraciones y alianzas estratégicas: ANATEL, SAG, asociaciones de municipios, Asociación de Clínicas, OAL, Ejército de Chile, Embajada de Haití, Intersector (MINEDUC, MIDESO, JUNJI, Integra, SS Niñez, SENAME, SENAMA, SAG, Gendarmería, entre otros) .

Sensibilización sociedad civil: COSOC-CDL, CAR, Escuelas de gestores sociales, escuelas de líderes sociales, Consejo Interreligioso, influencers haitianos

Contactabilidad, monitoreo y rescate: Rescate telefónico Y georreferenciación de grupos rezagados.

Reuniones con expertos y sociedades científicas y colegios profesionales: difusión de estrategias, terceras vocerías.

Vacunación a domicilio: de personas con enfermedades crónicas, considerando usuario/as con dependencias severas y personas mayores con movilidad reducida.

Vacunación extramural: Instalación de puntos masivos en puntos de alta afluencia.

Puntos de vacunación en hospitales y CAE: para abarcar población objetivo de las campañas.

ACCIONES INICIALES PARA LA RED ASISTENCIAL

- **Planificación para la complejización de camas** y preparación de los establecimientos con un enfoque anticipatorio, estableciendo medidas de alerta, niveles de riesgo y con acciones definidas para cada nivel de atención (APS, secundario y terciario).

- **Fortalecimiento anticipado de Unidad de Gestión Centralizada de Casos con profesionales médicos pediatras y adulto y no médicos para lograr cobertura 24/7.**

- **Abordaje intersectorial preventivo. Reprogramación de las vacaciones de invierno** para el 23/06/2025 en vez de iniciarlas durante el mes de julio, anticipando así el peak de VRS y otros virus que afectan principalmente a la población pediátrica.

LE 3. RESPUESTA DE LA ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD

RESPUESTA DE LA ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD

Aumentar la resolutividad de la atención primaria en patologías respiratorias mediante reforzamiento de los dispositivos de urgencia.

Refuerzo por profesionales kinesiólogos en horarios de alta demanda, así como del acceso a imagenología y laboratorio

Disminuir o evitar la ocurrencia de exacerbaciones o descompensaciones de patología de base durante el período invernal a través del refuerzo del control de salud de personas con condiciones crónicas.

Adecuado control de las condiciones crónicas de salud previo al invierno en personas de todas las edades, particularmente en aquellos con condiciones cardiovasculares, respiratorias y de salud mental

RESPUESTA DE LA ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD

CAMPAÑA INVIERNO 2025

- Fortalecimiento **oportuno** de las consultas y prestaciones de morbilidad.
- Extensión horaria en el funcionamiento de las salas respiratorias.
- Salas IRA/ERA, presentes en los **617** CESFAM del país, salas IRA, ERA o salas mixtas y en **100** Hospitales Comunitarios (médicos, kinesiólogos, enfermera)
- **Visitas domiciliarias** a población pediátrica con riesgo moderado/alto de morir por neumonia.

$6.658.056.000

Financiamiento campaña de invierno APS

para personal de refuerzo, extensión horaria y apoyo en SAPU –SAR en fines de semana y festivos, refuerzo de insumos y fármacos.

CAMPAÑA INVIERNO 2025

LE 4. RESPUESTA NIVELES SECUNDARIO Y TERCIARIO

RESPUESTA NIVELES SECUNDARIO Y TERCIARIO

1. **Gestión y preparación de oferta hospitalaria de camas**
   - Complejización a camas críticas
   - Hospitalización domiciliaria
   - Programa de Ventilación Domiciliaria
2. **Red de Urgencias**
3. **Servicios de Apoyo** (Laboratorio e imagenología)
4. **Refuerzo Unidad de Gestión Centralizada de Casos (UGCC)** a nivel central

$6.725.633.000

Financiamiento campaña de invierno Nivel Hospitalario

para personal de refuerzo en las diversas estrategias.

RESPUESTA NIVELES SECUNDARIO Y TERCIARIO

1. Gestión y preparación de oferta hospitalaria de camas

Tomando como referencia el 2024, el aumento de camas críticas se consigue "complejizando" disponible, modificando sólo la distribución en los niveles de cuidado.

Tipo de cama	UCI	UTI	UPC
Adulto	1.077	1.863	2.940
Pediatría	186	359	545

Tabla n°1: Dotación de camas críticas para adulto y pediatría. Chile, 2024.

Por tanto, el refuerzo de recurso humano (Profesional de enfermería, profesionales de kinesiología, TENS y médico) para la complejización de:

- **144 camas críticas adulto (47 UCI y 97 UTI)**
- **246 camas críticas pediátricas (98 UCI y 148 UTI)**

LLAMADO A LA ACCIÓN A LA COMUNIDAD

CAMPAÑA INVIERNO 2025

- **Vacunarse** quienes no lo han hecho
- **Prevención** aprendidas en pandemia
  - Higiene y lavado de manos
  - Ventilación de lugares
  - Uso mascarilla
- Saber **cuando consultar**
  - Salud responde ante dudas 600 360 7777
  - Preferir Atención Primaria de Salud (SAPU, SAR)
  - Alerta ante los signos de gravedad sobre todo en lactantes, infancias y adultos mayores.

EL PLAN DE INVIERNO ES DE TODOS